



Introducción a Terapia Ocupacional en Geriatría y gerontología I

Presente.

- INDICE:
- Clasificación de las lesiones cognitivas en el adulto mayor
- Etiopatogenia
- intervención Terapéutica desde el enfoque Ocupacional
- Actividad ocupacional



- ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
- ¿ QUÉ NOS INDICA CADA ARTÍCULO?
- ¿ QUÉ RELACIÓN TIENEN AMBOS ARTÍCULOS?
- <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-pdf-S0211139X19301908>
- <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-espanola-geriatria-gerontologia-124-pdf-S0211139X19301155>

- **Introducción a Terapia Ocupacional en Geriátría y gerontología I**
- La Terapia Ocupacional se desarrolló en España en el campo de la geriatría a principios de 1970, cuando en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid se creó un servicio de geriatría. A finales de los 70 se incorporó la figura del terapeuta ocupacional en las residencias de ancianos. En el año 1992 el terapeuta ocupacional apareció por primera vez en el Boletín Oficial del Estado como profesional de la geriatría y en el 2003 se reconoció a los terapeutas ocupacionales como profesionales sanitarios.
- La atención gerontológica tiene como objetivo prolongar los años de vida en buena salud y libres de discapacidad, y mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Al respecto, y relacionado con esto, la Terapia Ocupacional tiene una función esencial, promoviendo un envejecimiento satisfactorio y favoreciendo la autonomía y participación en la sociedad de las personas mayores.

LA OCUPACIÓN EN LA VEJEZ :

El colectivo de las personas mayores es una parte de la población especialmente sensible a la disfunción ocupacional. Esta pérdida en la capacidad para desempeñar ocupaciones en la persona anciana presenta algunas particularidades que las distingue de otras etapas vitales. En primer lugar, el proceso de envejecimiento conlleva, a su vez, a la aparición de una fragilidad ocasionada por la disminución de la reserva fisiológica del organismo y los cambios en los sistemas anatomofisiológicos, que es suficiente para provocar un principio de deterioro funcional, que si progresa lleva a la persona a una situación de vulnerabilidad que requiere la utilización de servicios sociosanitarios. Si estas necesidades no son cubiertas, se produce la dependencia, que, más tarde, puede llevar a la institucionalización y, finalmente, al fallecimiento



. Porcentajes de dependencia/independencia de las personas mayores en las AVD

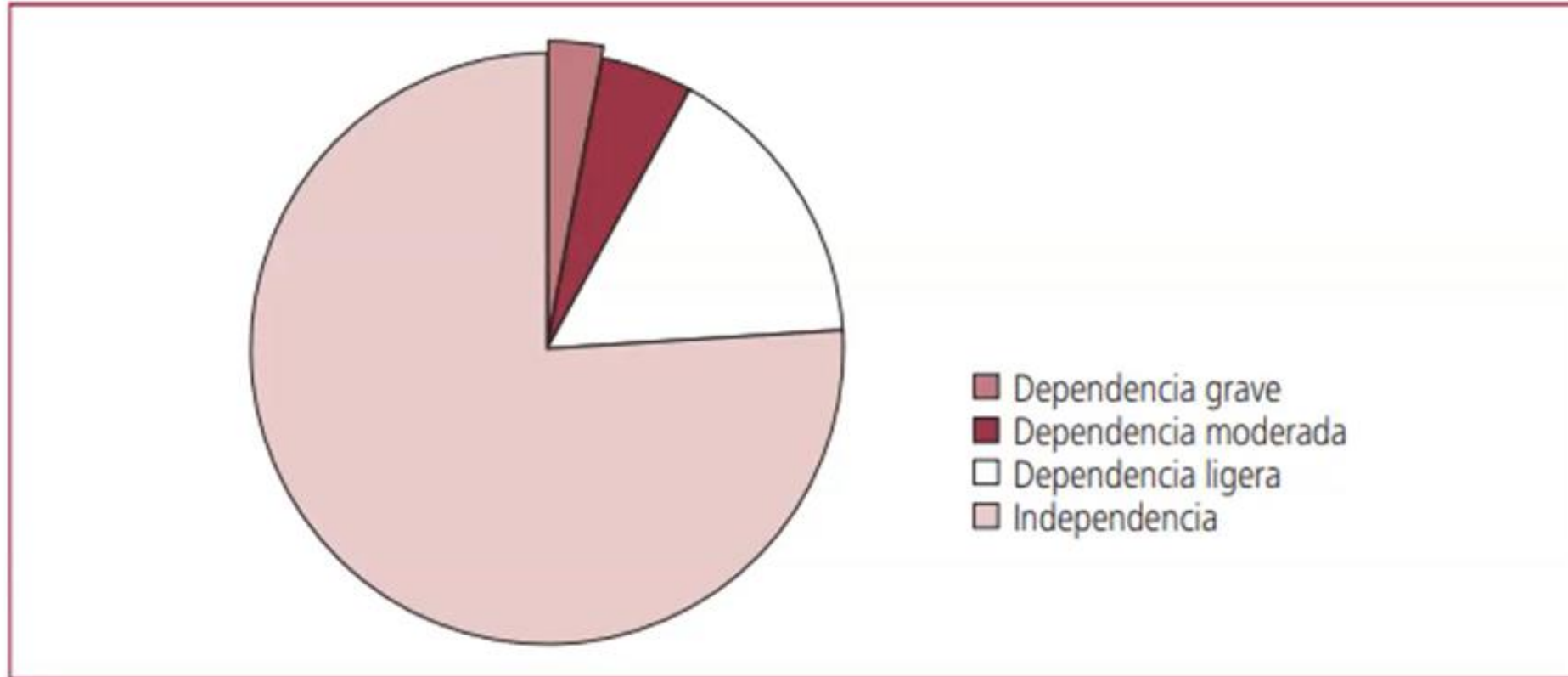


FIGURA 2. Porcentajes de dependencia/independencia de las personas mayores en las AVD^(17,18).

La Terapia Ocupacional mediante el uso terapéutico de las actividades de autocuidado personal, productivas y de ocio con el objetivo de aumentar la función independiente, reforzar el desarrollo y prevenir la discapacidad es coincidente con el enfoque principal de la gerontología y el de la asistencia sanitaria geriátrica. Por tanto, la Terapia Ocupacional es una disciplina esencial en Geriátrica, que puede desarrollarse ampliamente en sus diferentes enfoques:



- **Enfoque preventivo:** mantenimiento del estado de salud y prevención de la declinación funcional.
- **Enfoque adaptador:** uso de estrategias compensatorias para ayudar a los ancianos a vivir con una discapacidad.
- **Enfoque recuperador:** uso de técnicas de rehabilitación para ayudar a los ancianos a recuperar su función máxima.



- *Función preventiva:*
- Acciones graduadas y sistematizadas para la prevención y promoción de la salud, participando en la elaboración, aplicación y evaluación de planes o programas para personas mayores. Algunas de las acciones y objetivos del terapeuta ocupacional en este ámbito serían:
- Intervenir junto con otros profesionales en la planificación de proyectos e implementación de cursos de preparación para la jubilación.
- Intervenir junto con otros profesionales en la planificación de proyectos dirigidos a la eliminación de barreras arquitectónicas y a mejorar el acceso a los recursos en la comunidad.
- Planificar actividades que contribuyan en la integración de la persona mayor en la comunidad.
- Planificar, implementar y evaluar programas de estimulación y entrenamiento de la memoria con carácter preventivo.

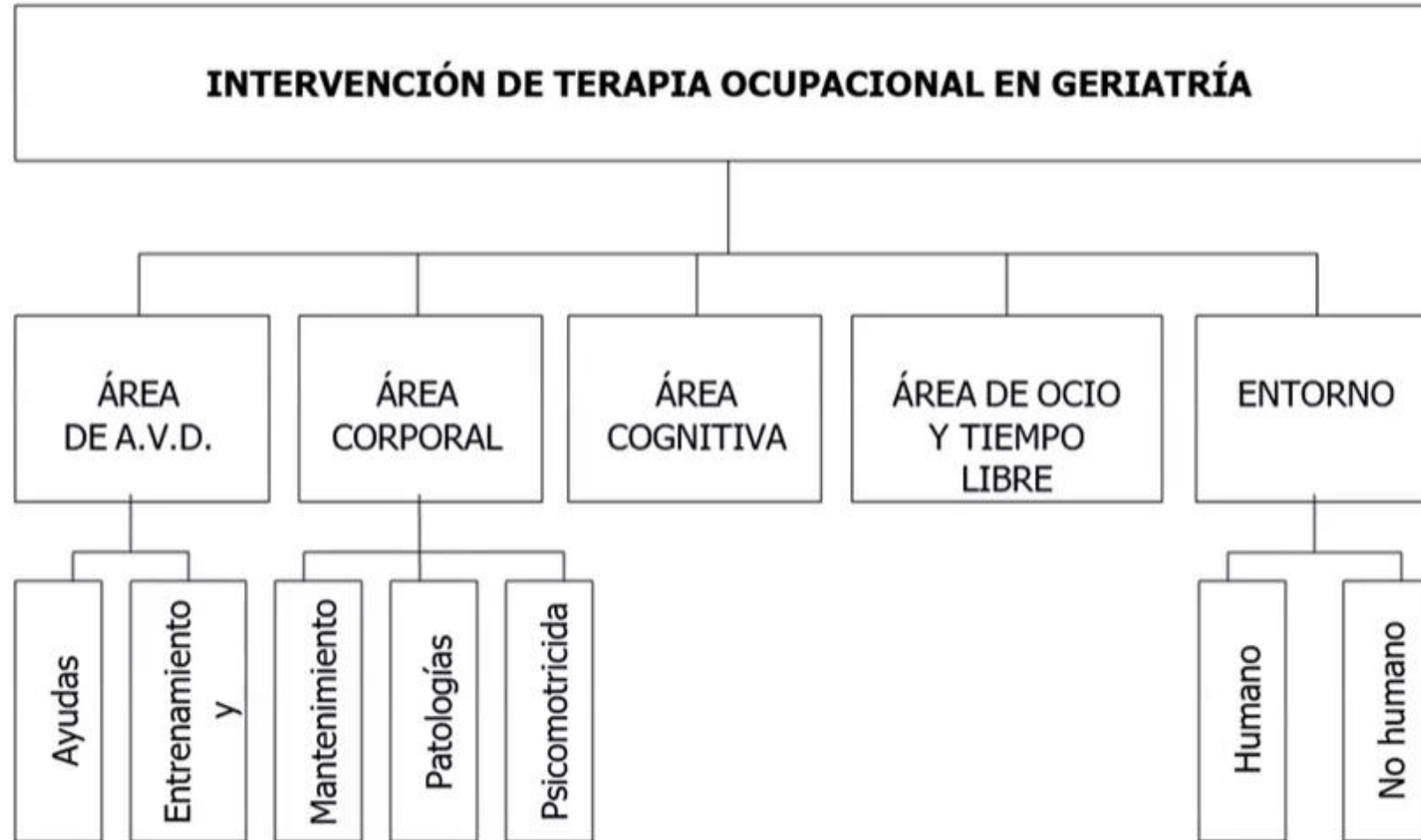


- **Función terapéutica:** son las acciones dirigidas al logro de la máxima expresión de las capacidades potenciales psicofísicas del individuo, orientadas a la interacción e integración sociocultural, utilizando como medio terapéutico la actividad.
-
- Conviene diferenciar entre las acciones correspondientes a la prevención secundaria y terciaria:
- **ENFOQUE ADAPTADOR:** tratamiento temprano en enfermedades, desarrollando capacidades potenciales y remanentes, así como disminuyendo la incidencia de mayores trastornos.



- **ENFOQUE RECUPERADOR:** instalada una disfunción o discapacidad, desarrollar capacidades potenciales y remanentes y evitar mayor deterioro. Es conveniente señalar otro tipo de intervención en caso de patologías crónicas evolutivas, por ejemplo demencias, implementando acciones tendentes a retrasar el deterioro; o realizando asistencia y/o acompañamiento de pacientes terminales





PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA MÁXIMA AUTONOMÍA EN LAS AVD

Podemos clasificar las AVD en las siguientes categorías:

AVD básicas: Son las actividades de autocuidado como asearse, alimentarse, vestirse, ser continente, desplazamientos.

AVD instrumentales: Son actividades más complejas y que nos indican la capacidad del sujeto para vivir de manera independiente en su entorno habitual. Incluyen actividades como encargarse de asuntos económicos, ejecución de las tareas del hogar, control de la medicación...



- **OBJETIVO PRINCIPAL**
- Mejorar y/o mantener la máxima autonomía en las AVD.
- **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
- Adquirir, mejorar y potenciar las habilidades necesarias para un correcto desempeño en las AVD
- Recuperar, estimular y mantener aquellos hábitos que ya tenían
- Proporcionar instrucción y entrenamiento en las AVD lo más personalizada posible



- **AREA CORPORAL**
- Se recogen en esta área los programas encaminados a mejorar y/o mantener el estado físico general, evitar el deterioro físico producida por la inactividad psicofísica y el sedentarismo, favorecer el autoconocimiento del cuerpo y las relaciones con el entorno e interpersonales y a recuperar la autonomía y funcionalidad perdida después de una enfermedad o un proceso incapacitante.
-

- Tablas de gerontogimnasia: rutinas de ejercicios cuyo objetivo es la movilización de todas las articulaciones del cuerpo.
- Relajación: Distintos métodos y técnicas cuya finalidad es ayudar a que el sujeto tome conciencia de su cuerpo, lo sienta y lo perciba en tensión y distensión, en movimiento y en reposo e incorpore estas sensaciones a otras ya acumuladas en su cerebro, para que pueda adquirir una buena imagen corporal.
- Actividades deportivas: fútbol, baloncesto, atletismo...
- Paseos

- Enfermedad de Parkinson:
-
- Facilitación neuromuscular propioceptiva
- Higiene y tratamiento postural
- Ejercicios graduados de resistencia para incrementar fuerza y coordinación
- Estimulación auditiva para favorecer la movilidad corporal por medio de marcha rítmica, danza, aplausos y cantos, ya sea de forma individual o grupal.
- Deportes para favorecer la motivación, la socialización y el movimiento.
- Actividades manuales para mantener la coordinación de motricidad gruesa y fina y la fuerza.

- Accidente cerebrovascular:
-
- Técnica de Bobhat en las AVD para facilitar el movimiento
- Actividades bimanuales, en el caso de que exista hemiparesia, para favorecer el movimiento del miembro afectado.
- Tratamiento postural
- Técnicas de estimulación cognitiva

- **PROGRAMA DE PSICOMOTRICIDAD**
-
- La psicomotricidad es la educación del movimiento o por el movimiento procurando una mejor utilización de las capacidades psíquicas.
- **ACTIVIDADES Y TÉCNICAS**
- Actividades motrices básicas: movimiento libre o dirigido, ejercicios de coordinación, recorridos, marchas, laberintos...
- Actividades somatognósicas: actividades que implican el conocimiento y movimiento de las distintas partes del cuerpo, discriminación de izquierda y derecha...
- Actividades sensoriales:
- Actividades para trabajar el ritmo
- Actividades de orientación temporo-espacial

- **AREA COGNITIVA**
- Entendemos por cognición el conjunto de capacidades cerebrales superiores que nos permiten interpretar el medio que nos rodea y dar respuestas adecuadas a las situaciones que éste nos plantea. Esto es, capacidades como la atención, la concentración, la memoria, la orientación, el cálculo, etc.
- **Programas de estimulación y actividad cognitiva:**
- La estimulación cognitiva tiene el propósito de “animar a la acción o ejecución”. Representa, en cierto modo, un tipo de “gimnasia cerebral”. Los ejercicios que se proponen en este ámbito tienen como objetivo estimular las habilidades mentales del paciente. Se trata de trabajar el lenguaje, la memoria, los sentidos, el cálculo... Se fundamenta en los principios de la rehabilitación neuropsicológica y de la plasticidad cerebral



- **Reminiscencia:**
- Constituye una forma de reactivar el pasado personal y de ayudar a mantener la propia identidad, pensando o hablando sobre la propia experiencia vital. Estos recuerdos se utilizan para centrarle en el presente, para fomentar la comunicación y la interacción social compartiendo experiencias y para proporcionar espacios de disfrute y entretenimiento.
- La reminiscencia se puede realizar de forma estructurada en una sesión preparada de antemano o en otros contextos de una manera informal. Cualquier estímulo que evoque recuerdos (una fotografía, un sonido, un olor,...) puede actuar como primer elemento de una cadena de recuerdos. Es importante tener en cuenta la realidad de cada persona y emplear elementos relacionados con su biografía.



- **AREA DE OCIO Y TIEMPO LIBRE**

- Se agrupan en esta área los programas y actividades cuyo fin es conseguir el máximo grado de bienestar y satisfacción personal por medio del recreo y disfrute de una amplia gama de actividades lúdicas y recreativas y lograr que el tiempo libre sea transformado en tiempo de disfrute, de creatividad y de juego.
- La intervención de la terapia ocupacional en esta área será distinta según la población a la que se dirija. En el caso de sujetos autónomos y que vivan en la comunidad la línea de acción será asesorar e informar sobre los distintos recursos de ocio en su entorno próximo y capacitar al sujeto para que haga uso de los mismos.



-

- **ACTIVIDADES Y TÉCNICAS**

-

- Actividades lúdicas: se engloban en estas juegos de mesa, juegos colectivos tradicionales y juegos competitivos.
- Actividades creativas: cestería, cerámica, manualidades, costuras
- Actividades musicales: baile, danza, canto
- Dinámicas de grupos: tertulias, teatro...
- Participación en fiestas
- Salidas y excursiones
- Información y entrenamiento en habilidades de búsqueda de recursos comunitarios de ocio



EL ENTORNO

- El entorno se refiere al conjunto de personas, lugares, objetos y circunstancias que rodean a la persona y con los cuales está en constante interacción.
-
- El desempeño ocupacional de una persona viene determinado por una parte, por las capacidades y características personales del sujeto y , por otra, por las exigencias y las oportunidades que proporciona el medio en el que se desenvuelve. La intervención de la terapia ocupacional se dirigirá, por tanto, a tratar de modificar ambos tipos de factores con el objetivo de optimizar dicho desempeño ocupacional.



- ENTORNO NO HUMANO O FÍSICO:
-
- El entorno no humano comprende los espacios físicos en los que vive la persona y los objetos que existen en ellos y con los cuales interactúa. Resulta fundamental dentro de la intervención de terapia ocupacional una evaluación adecuada de este entorno, de cara a detectar problemas, riesgos y limitaciones y a realizar las adaptaciones necesarias adecuando el entorno a las necesidades específicas de la persona mayor.



- Adaptación cognitiva y funcional del entorno físico:
- Esta línea de acción se centra en el medio externo. Se pretenden compensar las limitaciones y facilitar los rendimientos del paciente para que presente, consecuentemente, un menor trastorno funcional. Para conseguir este objetivo el entorno deberá ser sencillo, estable y seguro.



- **ENTORNO HUMANO:**
-
- La actividad sobre el entorno humano va dirigida tanto a la familia como a los profesionales que atienden a la persona. Las actitudes, habilidades y conductas de las personas con las que interacciona el sujeto influirán decisivamente en su desempeño ocupacional, por lo que en ocasiones el trabajo del terapeuta ocupacional se dirigirá a modificar y/o mejorar dichos aspectos.
- **Técnicas de comunicación:**
- Se basan en los principios de simplificación de los mensajes, en la combinación de informaciones verbales con la comunicación no verbal y en la regulación de las distancias y las posiciones entre el cuidador y paciente.
- **Manejo conductual:**
- Una adecuada actitud y manejo por parte de los cuidadores pueden servir para prevenir o cuando menos, minimizar muchos de los trastornos de conducta que presentan las personas mayores con determinadas patologías, fundamentalmente en el ámbito de la psicogeriatría





Presente.